

2장. 소아의 진단

1절. 개요

▶ 진단의 방법

- 소아과는 진단은 어렵고 치료는 쉽다.
- 열 명의 남자보다 한 명의 부인을 치료하기 어렵고, 열 명의 부인보다 한 명의 소아를 진료하기 어렵다

why? 啞科 : 아이들은 표현을 잘하지 못한다. 그러므로 성인에 비해 어려움이 있다

- 望診 중시 : 小兒惟以望爲主, 問繼之, 聞則次 《幼科鐵鏡》

▶ 연령에 따른 진단법

1. 일반통용진단법 : 觀形察色, 舌診, 聽聲音

- ① 생후 12개월 까지 : 望診, 聞診, 額脈
 - ↳ 검지, 중지, 약지로 이마를 짚는다
- ② 2-6세 : 望診, 聞診, 虎口三關脈, 1指로 人迎氣口脈
- ③ 7~14세 : 1指로 移指三部脈
 - ↳ 손가락 하나로 이동하면서
- ④ 14세 이상 : 어른과 같이 진단

2. 額脈診斷(일종의 切診)

- 대상 : 초생아 ~ 생후 12개월
- 방법 : 눈썹 위 이마로부터 발제 이하 사이에 식지를 위로 하고 중지 무명지의 손으로 세 손가락을 대고 寒熱이 감지되는 부위와 차도에 따라 병인을 진단.
- 아이의 오른쪽 이마 = 의사의 왼손 사용, 아이의 왼쪽 이마 = 의사의 오른손 사용
- 식지, 중지, 무명지 외의 무지, 소지는 머리와 이마에 닿지 않게 한다.
- 진단범위가 극히 한정(外感, 乳傷, 驚症類), 이 외의 병증은 적음

三指俱熱 : 外感寒邪, 鼻塞發熱, 咳嗽, 聲粗

↳ 감기의 증상으로 같이 잘 때 아이의 호흡을 통해서 쉼쉼거리는지, 코가 막혔는지, 기침을 하는지 등을 파악

三指俱冷 : 吐瀉, 臟不安

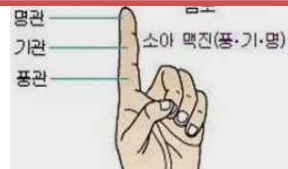
↳ 교과서에 나온 나머지 개념들은 의미가 거의 없음...

3. 虎口三關脈

- ↳ 현대 임상에서는 큰 의미가 없음. 질병에 따라 색이 다르다는 것!
- 대상 : 생후 1년~6세, 3세 이내가 바람직
 - ↳ 3세 이후로는 손이 많이 사용하여 변형이 올 수 있음
- 소아의 식지(검지): 소아의 식지 장면에 붉은 문선이 나타나면 질병의 발생을 뜻하며, 질병에 따라 문선의 형상, 색이 다르게 나타난다.

- 손톱까지 가면 위험.

- 虎口三關脈은 문선의 색상이나 형태를 보는 것으로, 切診이 아니라 望診에 포함된다.



제3절 : 命關 위중한 병

제2절 : 氣關 진행된 병

제1절 : 風關 가벼운 병

손가락을 꺾꺾 밀어서 혈관을 나오게 해서 색을 본다

- 명관에서 풍관 쪽으로 가볍게 밀어서 식지 안쪽의 淺靜脈을 관찰

√ 정상지문

: 紅黃色을 띠며 은은하여 風關 이상까지 드러나지 않는다.

√ 병리지문 :

浮沈은 表裏, 紅紫는 寒熱, 淡滯는 虛實, 三關은 輕重을 예측.

- 풍관에 나타남: 병의 초기,증이 가벼움
- 기관에 나타남: 질병이 진행되어 병사가 성함
- 명관에 나타남: 질병이 위중함
- 손톱까지 直透: 위험한 단계

√ 三關脈의 관찰

紅→紫→靑→黑(純黑은 불치) : 점점 악화되는 상태

- ① 紫-風病(급경풍에 의한 울혈→자색)
- ② 紅-傷寒(감기)
- ③ 靑-驚(놀라서)
- ④ 白-疳(영양실조)
- ⑤ 黑-中惡(나쁜 기운을 받아서)
- ⑥ 黃-困脾(비위기능 감약)

4. 人迎氣口脈

- 人迎脈과 氣口脈의 상응관계로 陰陽의 有餘와 不足 및 平, 不平을 파악한 것이다.

<소문 음양별론> “三陽在頭, 三陰在手”에서 頭는 인영을, 手는 기구를 말한다. 이 모두에서 장부의 기를 살필 수 있다.

人迎	結喉兩傍 1촌 5분	경동맥	양명의 기	삼양 대표	외, 표	육부
氣口	手魚際之後 1촌	요골동맥	태음의 기	삼음 대표	내, 리	오장

성쇠가 없이 박동이 계절에 따라 일정하게 유지되는 맥상을 음양의 유여와 부족이 없는 정상상태의 질병이 없는 평인으로 정의하였을 때, 인영맥과 기구맥을 비교하여 오장육부의 상태를 알 수 있다.

2절. 四診

▶ 望診 (망진)

1. 望神色 ★★★

- 神 : 소아의 정신상태를 지칭한다
- 色 : 얼굴의 기색을 말한다
- 장부기혈의 성쇠와 병정의 경중과 예후를 판단한다
- 소아는 원기가 있고 / 눈이 반짝이며 / 기백이 넘치고 / 얼굴은 붉고 윤이 나고 / 호흡은 고르고 نرم / 사지의 움직임이 활발하면
→ 정상이다
- 정상 소아의 얼굴색은 “홍윤광택”하다.

1-a 五色主病 ★(8개년)

- * 靑 : 主驚, 主痛, 主瘀血
- 面靑白 / 얼굴과 눈썹을 찡그린다 → 裏寒복통
- 面靑而晦暗, 神昏抽搐 → 경풍과 전간의 발작시
- 面靑脣紫, 呼吸促急 → 氣血瘀阻, 肺氣閉塞, 중증폐렴, 심부전. 폐섬유화 같은 폐기폐색

* 紅(赤) : 主熱

- 面紅目赤, 咽痛脈浮 → 風熱외감

- 午後顴紅 → 陰虛內熱, 폐결핵시 나타남

* 黃 : 主虛(脾虛), 主濕

↳ 소아는 비계질환이 많은 편

- 面目色黃而鮮 : 濕熱內蘊의 陽黃, 간염이나 담도질환시 나타남
- 色黃而晦暗 : 寒濕阻滯의 陰黃, 폐색성 黃疸 등에 나타남
- 생후 1주 이내 신생아의 面目黃 : 생리적 黃疸

* 白 : 主寒, 主虛(肺虛)

- 面白浮腫 : 陽虛水泛, 신염 등에 나타남
- 面色慘白, 四肢厥冷 : 陽氣暴脫, shock시 나타남
- 面白乏華, 脣色淡白 : 血虛, 빈혈시 나타남

* 黑 : 主寒, 主痛, 主水濕停飲, 爲惡候

- 식중독이나 병정 위중시 나타난다.
- 紅黑潤澤 : 신체가 건강하고 先天腎氣의 충족을 의미

1-b 얼굴의 부위(五部)에 따른 색의 변화

- 五部 : 左腮爲肝, 右腮爲肺, 額上爲心, 鼻爲脾, 頰爲腎
- 《小兒藥證直訣 面上證》

↳ 인체 부위에서 청적황백흑을 따져서 상극의 색이 나타나면 ~~다 라고 해석하

는 것은 큰 의미가 없다. 각 부위의 색을 비교하기 보다는 전반적인 색을 보는 것이 중요하다

2. 望形態 : 모양과 움직이는 상태 등 ★(6개월)

- 形은 形體, 態는 動態를 의미
- 身體의 強弱肥瘦와 動靜狀態를 觀察하는 것

2-a 形體 형체

- 形體의 望診은 머리와 몸, 전신, 피부, 모발, 손발톱을 포괄
- 발육이 정상, 筋骨이 튼튼하고, 肌肉이 풍부하고 皮膚에 潤澤이 있으며 毛髮이 黑色이면서 潤이 나고 활발하게 움직이면 건강
- 筋骨이 軟弱, 몸이 瘦瘠하고 피부가 건조하고 모발이 萎黃하고 顙門의 폐쇄가 지연되고 활기가 없으면 병이 있는 것
- 대천문은 18개월에 폐쇄되는 것이 정상이다

√ 머리

★ 머리머리가 모나고 머리카락이 적고 대천문 폐쇄지연 : 五遲症

★★★ 머리가 크고 턱이 수축되어 있으며 대천문이 열려있고 눈꺼풀이 쳐져 있음 (뇌수종) : 解顙

★ 근육과 피부가 부드럽고 피부가 위황 ★ : 脾虛氣弱

★★★★★★ 천문과 안검이 움푹 들어가 있고 피부가 건조 : 영아설사로 인한 탈수

★★★★★★ 복부팽대하고 사지는 말라 있고 머리카락이 드물며 이마 위에 청근이 나타남 : 疳症

★★ 모발이 마르고 황색이면서 머리숱이 적고 잘 빠짐 : 氣血虧虛

√ 손발톱

손발톱이 약하고 창백하며 질이 나쁨 : 營血虛虧의 증증

★ 손발톱이 자색이고 곧봉지 : 心陽不足, 氣血瘀滯, 선천성 심장질환에서 볼 수 있음.

2-a 동태

★★★★★ 목이 뻣뻣, 경련, 심하면 角弓反張 :

경풍 (간질이나 파상풍 등 풍증)

★★★ 앉은 자세로 喘症, 천명이 들림 : 천식

데굴데굴 구름, 울고 손으로 배를 끌어안는 것 : 급성복통

3. 察苗竅 : 目, 鼻, 耳, 口, 舌, 前後二陰를 살피는 것 ★★★

苗竅(모구) = 目, 鼻, 耳, 口, 舌, 前後二陰을 지칭한다.

3-a 舌 ★(8개년)

- 정상소아의 舌體는 淡紅潤澤하고 신축활동이 자유롭다.

- “辨舌質可辨五臟之虛實, 辨舌苔可察六淫之淺深”

- 혀의 색 : 병사의 성질과 관련이 있음

- 설질 : 병의 경중, 병세의 진행도, 진액변화, 邪五消長과 관련

=> 음식물 섭취로 인한 오염과 구별해야 한다

3-a-1 설질

舌質淡白 : 氣血虧虛, 脾腎陽虛, 水濕痰飲停滯

舌質紅絳 : 邪入營血

舌紅無苔 : 陰虛津少

↳ 원래는 박백태가 있어야한다 없는 것은 유두수축 = 음허

舌質紫紅, 紫暗 : 氣滯血瘀

舌體腫大, 舌色青紫而暗 : 中毒 -> 식중독, 약물중독

舌有芒刺 : 熱盛傷津 -> 혀바늘 있고 딸기처럼 부어올랐을 때.

吐舌(舌吐脣外, 緩緩回收) : 心脾積熱 -> 혀를 내밀고 있는 모습. 열이 있어 시원하게 만들기 위해 혀를 내밀고 있는 경우

弄舌(舌出脣外, 躁動不寧) : 心脾積熱, 驚風前兆, 大病後心氣不足,

지능발육불량, 습관 -> 혀를 넣었다 뺐다를 반복하는 모습

3-a-2 舌苔

- 백-표 황-리
- 설태의 색은 병사의 성질과 관련
- 설태질은 병정의 경중, 병세의 진행도, 진액 변화, 사정소장과 관련
but 음식물섭취로 인한 염태와 구별해야한다.

色白 : 寒, 表

白膩 : 寒濕內滯 -> 소화가 안되어 흰 태가 두껍게 낀 것

轉黃 : 表邪入裏

色黃 : 熱, 裏

黃膩 : 濕熱內滯

熱病苔剝 : 傷陰 -> 오랜 병으로 설태가 벗겨지고, 유두가 위축되어 매끄

럽게 보임. 경면설

舌質花剝 地圖象 : 胃之津液不足

苔薄 : 表邪, 病情이 輕함

苔厚 : 裏邪, 病情이 重함

舌質花剝 地圖象 : 胃之津液不足 > 지도설 鏡面舌. 위음, 폐음부족에 의해 생김

無苔 : 正氣不足 > 면역력 부족

* 혀와 관련된 양방 진단

■ 혀가 커져있는 경우

- Beckwith Wiedemann 증후군
- 혈관종, 림프관종

■ 마른 혀

- 탈수
- atropine중독
- 쇼그렌 증후군

■ 딸기 모양 혀

- 성홍열 (연쇄상구균 감염)
- 가와사키병 (면역질환, 원인불명 급성 열성 혈관염)
- Tersinia pseudotuberculosis감염

■ 지도설 (과거 병적으로 보지 않았으나 요즘에는 양방에서 병적으로 본다)

- 원인은 밝혀지지 않았으며 자극성 음식에 의해 악화된다.
- 아토피가 있거나, 빈혈, 당뇨, Reiter병, 지루피부염, 화농성 건선

■ 잘 떨어지지 않는 백태

- 아구창(thrush)

■ Aphthous궤양

- 혀 끝에 나타나며, 매우 아프다.

■ Herpetic gingivostomatitis

- 궤양 형태로 혀의 어느 부위에 나타나며 수가 많다.

3-b 目(眼神과 眼瞼, 眼球, 瞳孔, 公막, 결막 관찰)

眼瞼結膜 色淡 : 血虛, 貧血

鞏膜 色黃 : 濕熱蘊의 黃疸, 급성간염

眼瞼浮腫 : 水濕上泛, 급성사구체신염★

眼窩內陷, 哭而無淚 : 脫水

兩目上竄 : 驚風發作

3-c. 鼻(코의 분비물, 형태)

鼻塞流清涕 : 風寒感冒

鼻流黃濁涕 : 風熱感冒

鼻衄 : 肺經有熱, 血熱妄行, 혈소판감소자색반 ★

鼻孔乾燥 : 肺津已傷, 外感燥邪

鼻翼扇動(코를 벌름벌름) : 肺氣閉塞, 肺炎

3-d. 口 (색, 潤燥, 外形)

脣色이 淡白色 : 氣血虧虛

脣色이 靑紫色 : 寒, 瘀血

脣色이 鰓두색 : 暴瀉氣陰兩傷 설사를 많이 해서 다 없음

口脣乾燥 : 傷津

잇몸이 紅腫 : 胃火上衝

★口角流涎 : 胃熱, 脾虛不能固攝

목의 편도선이 부은 것 일 수도. 속이 차면 맑은 침. 위열이 있으면 끈적이는 침. 구내염이나 편도염이 있을 때는 침 삼키는 게 어려워 침을 흘림.

★ 이가 나지 않는 경우 : 腎氣不足

★ 咽頭가 붉고, 扁桃腫大, 發熱 : 外感風熱, 肺胃之火上炎, 急性 扁桃腺炎

★ 扁桃의 흰 막 : 연쇄상구균감염, 디프테리아(두꺼운 녹색 위막)

扁桃의 한쪽만 큰 경우 : 편도 주위 농양, 종양 등

3-e. 耳

귀가 아프고 삼출물이 나오는 경우 : 肝膽火旺, 中耳炎

귀안이 아프다 + 삼출액 = 중이염

耳垂중심의 漫腫 : 유행성 이하선염

★ 이통 이명 : 왼 = 병적 / 오른쪽 = 회복중인 상태 (air fluid level 형성)



3-f. 二陰(외생식기와 항문)

陰囊이 때로 붓고 울면 더 심해지는 경우 : 疝氣

cf. 氣疝(탈장), 水疝(음낭수종)

陰囊과 陰莖이 浮腫 : 腎病의 표현

영아의 항문이 潮濕紅痛 : 기저귀피부염

항문주위를 긁는 것 : 요충병

대변이 딱딱하고 피가 나오는 경우 : 항문의 열상

排便後 直腸脫出 : 中氣虛 脫肛

4. 辨癩疹

▶ 丘疹

- 피부 표면에 융기된 병변, 風熱, 血熱, 濕熱의 소치이며, 만성은 氣滯血凝으로 생긴 것이다.

▶ 斑

- 피부 표면에 융기, 함몰이 없이 피부색의 변화가 나타나는 병변
- 紅色이면서 누르면 색이 없어지는 것 → 氣分有熱,
- 눌러도 안없어지는 것 → 血分有熱 혹은 血凝이다.
- 紫色 → 血分熱盛하거나 脾不統血로 인한 것이다.
- 黑色斑 → 熱毒이 극한 것이고
- 白色斑 → 氣血失調로 인한 것이다.

▶ 水疱

- 맑은 액체가 들어있는 물집
- 濕熱, 熱毒, 寒濕不和로 인해 일어난다.

▶ 膿疱

- 농을 포함한 융기성 병변
- 熱毒에 의해 발생한다.

▶ 結節

- 구진보다 크고 단단하며 피부 심부에 위치
- 氣滯血瘀, 阻塞經絡으로 인해 일어난다.
- 피부색이 변하지 않는 것은 痰濕聚結, 寒濕凝結에 의한다.

▶ 風團 : 일과성 부종성 병변

- 색은 風寒 혹은 陽氣虛弱, 紅色은 風熱 혹은 陰虛火旺으로 나타난다.
- cf. 자반은 血熱과 脾不統血로 인해 나타나는 경우가 많다.

▶ 鱗屑

- 피부 표면으로부터 탈락되는 층상의 각질
- * 건성은 血虛風燥, 肌膚失養, 油膩性 鱗屑은 濕蘊肌膚,
- 肝腎不足도 인설을 일으킬 수 있음

▶ 糜爛

표피가 떨어져 나간 것, 濕熱, 脾虛으로 인한

▶ 痂(가피)

혈청, 농, 혈액 등이 건조되어 나타나는 병변

▶ 抓痕(찰상)

긁어서 생긴 병변

▶ 皸裂(균열)

표피에 생기는 선상의 틈, 燥 血虛 등

▶ 潰瘍

표피와 함께 진피까지 소실된 병변

▶ 苔蘚化

- 표피와 진피 일부가 두꺼워져 가죽처럼 두터워진 상태
- 만성 소양성 피부질환의 주요 임상 표현으로 血虛, 血燥, 寒濕內阻에 의한다.

▶ 색소침착

- 만성 피부질환에 나타난다.
- 淡褐色은 血弱失華에 속하며 黑褐色은 腎虛에 속한다. 색이 옅은 것은 병후 氣血違和한 것이다.

5. 望二便 ★★★

- 신생아 및 유아의 대변은 비교적 묽음
- 정상 소아의 대변은 황색이며, 농도는 적당하다.

大便燥結：實熱，陰虛內熱

大便稀薄，白色 덩어리를 포함：內傷乳食

大便稀薄，色黃 穢臭：濕熱積滯，세균성이질

大便稀薄，혈액과 점액이 포함된 변，주기적으로 온다

：장중첩증 (구토, 복통, 혈변이 주기적으로 온다.)

- 綠色便：

① 嘔吐，發熱이 동반되거나，변이 稀薄軟數해지고 痰，血，便이 섞여 있으면 → 대개 腸의 이상

② 다른 증상이 없으면 → 채소，母乳의 前乳만 먹인 경우 등 음식의 종류에 의한 것

小便黃赤短澀：濕熱下注

(요도염, 방광염 등의 염증, 오줌소태)

小便混濁如米泔水：飲食失調(食積. 소화가 안되면 쌀뜨물처럼 소변)

小便色紅，多褐色：혈뇨

小便色深黃：濕熱內蘊，황달

2. 聞診 (문진)

聞診은 聽覺(청각), 嗅覺(후각)으로 질병을 식별하는 진단방법이다.

1. 聽聲音 ★★★(7개월)

- 울음, 말, 기침, 호흡, 딸꾹질, 트림소리 등을 포괄
- 소리의 변화를 들어 질병의 성질을 식별한다.

1-a 啼哭聲(울음)：병적인 울음 감별 필요

- 갑자기 큰소리로 자지러지게 울 때：장중첩증아아, 영아산통

↳ 영아 복부 평활근이 단축되는 것

↳ 장중첩증：회맹쪽에서 장이꼬인 것을 말함. 1~2분 정도의 간헐적 통증

- 날카로운 울음소리：뇌막염, 중추신경장애(핵황달 등)

↳ 장중첩증핵황달, 뇌막염 - 눈동자가 하찬(내리 감) ★★★

- 약하고 쉼 울음소리：선천성 심질환, 크레틴병 ★

- 쾅쾅하는 울음：후두염 (barking cough)

- 신음하는 것 같은 울음：호흡곤란 증후군, 폐렴

- 고양이와 우는 소리 같은 울음：묘성증후군

- 어린 양의 울음소리：Cornelia Lange 증후군 ★

↳ 3번 염색체이상 성장장애 팔다리 짧고 다모증

1-b 言語聲(肺氣와 연관) : 입 인후등과도 연관

- 소리 크고 낭랑하고 말이 많고 躁動 : 實證
- 작고 낮고 힘없음 : 虛證
- 갑자기 목소리가 쉰 경우 : 인후나 성대질환
- 크고 높고 날카로운 소리로 허리를 구부리며 운다 : 복부 극렬한 통증
- 헛소리, 소리가 높고 힘이 있으면서 의식이 맑지 않다 : 熱擾心神 ★
- 말을 더듬는 경우가 많음 : 高熱傷津이나 痰涎壅塞

1-c 咳嗽聲 : 소리와 痰聲의 유무변화에 주의

- 기침소리가 맑고 높으며 코가 막히고 콧물나는 경우: 外感風寒 ★★
- 기침소리가 무겁고 맑지 못하며 가래있는 경우: 肺熱痰濁 ★★
- 마른 기침, 가래가 없거나 담이 적고 끈끈한 경우 : 燥邪犯肺
- 발작성 연속적 기침 : 백일해, 이물 흡입 ★★★★★
 - ↳ 백일해 : Whooping cough -기침끝날때 흡~ 하면서 끝난다.
- 쿵쿵 짚는 기침 : 디프테리아, 후두염, 후두개염 ★
 - ↳ Barking cough
- : 세균성(디프테리아) : 진성
- : 바이러스성(인두염, 후두염) : 가성
- 잠잘때나 기상 시에 가래를 뱉으려고 하는 기침 : 부비동염★★

1-d 呼吸音 : 천식환자, 코막힘 구분

- 호흡이 빠르고 입으로 숨쉬면 : 鼻塞
- 호흡이 거칠고 힘있으면 : 肺熱上搏
- 호흡이 빠르고 천명이 들리면 : 천식 痰壅氣道 ★★
- 코를 벌름거리며 호흡이 급박하고 發熱咳嗽 : 폐렴★★
- 호흡이 급박하고 얼굴에 청색증 : 호흡기 이물폐색 ★

1-e 噦逆

- 생후 몇 달 동안은 젖을 먹고 난후 딸꾹질하는 아이 많다.
신경근육계의 미숙으로 인한 것으로 생각됨
- 젖을 먹은 후 위가 늘어났을 때 잘 일어남
- 이런 딸꾹질은 병으로 보지 않는다
- 소화 덜 됨 or 차가움(오랜 기저귀) or 과식에 의해 발생
- 만약 큰 병이나 오래된 병중에 딸꾹질이 끊어졌다가 다시 나고 이마에 식은땀이 나면 위중한 증후로 예후가 불량하다.

1-f 噯氣聲

- 신트림이 나오는 경우 宿食積滯가 많음 ★★
- 평상시 포식 후에 나오는 트림은 병리적 상태가 아니다
- 트림시 시큼한 냄새가 나면 속식적체가 많다

2. 폐와 심장의 청진 ★(5개년)

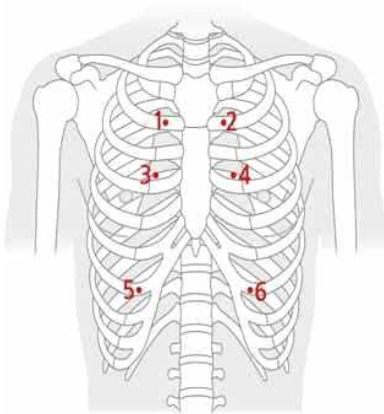
(1) 폐의 청진

정상호흡음과 비정상 호흡음을 구별해야 한다.

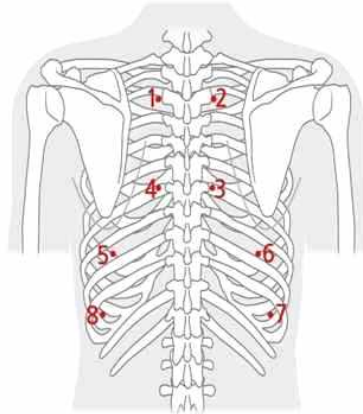
- 정상 호흡음 : vesicular, bronchial, bronchovesicular
- 비정상 호흡음 : crackles, wheeze

청진시에 smooth한지 coarse한지를 구분해야!

- ① 폐음을 들을 때는 apex에서 basal쪽으로 내려가면서 좌우를 비교
- ② 위에서부터 아래로 내려가면서 유두의 바깥쪽으로 지나도록 한다.
- ③ 뒤쪽에서 들을 때는 scapular의 medial border를 따라서 청진한다.



(앞쪽)



(뒤쪽)

(2) 심장의 청진

* 청진시 주의할 점

- 수면중이거나 젖 먹이면서 듣는 것이 좋음

why? 울기 시작하면 심음이나 심잡음을 듣기 힘들어짐

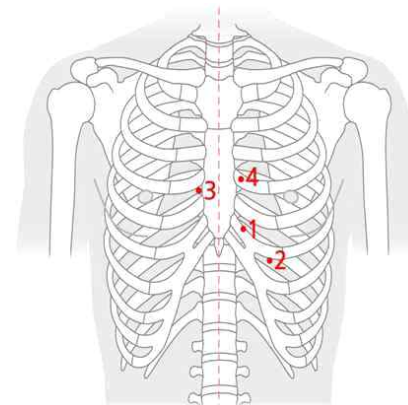
- 호흡에 의한 잡음이 들릴 때 → 심음이나 잡음을 듣기 어렵다. 큰 소아에서는 숨을 내쉬고서 잠시 숨을 멈추도록 하고 들으면 잘 들린다

- 체위를 변경하여서 들어보도록 한다. 앉아서 들어보고 누워서 들어본다, 무해성 잡음은 누운 자세에서 잘 들리는 수가 적지 않다

- 심방중격결손, 심실중격결손의 murmur은 누운자세에서 잘 나타남

- 대동맥 폐쇄부전의 확장기 잡음 : 좌위에서 전굴위로 했을 때 잘 들린다

* 청진의 진행순서



(3) 臭氣味 - 분비물, 배설물 냄새 것 포함

□臭(穢) : 胃熱鬱蒸, 濁氣上升

□臭(腐) : 잇몸의 종창 궤양

□臭(腥), 피비린내 : 血症 (잇몸출혈, 코피)

膿血이 섞이고 비린내가 나는 가래를 토하고 발열을 겸

: 熱毒壅閉, 鬱結成膿의 폐옹

3. 聞診 (문진)

▶ 나이

▶ 主訴와 기간

▶ 現병력 :

- 주소를 구체적으로 설명(主訴≠질환명)
- 기간, 위치, 진행양상, 수반증상, 치료력(효과 유무)

▶ 과거력

- ① 산전(임신 중 산모의 건강상태, 약물 복용 등)
- ② 출산(체중, 분만상태, 출생시 상태 등)
- ③ 신생아(색깔, 울음, 과잉점액, 황달, 기형 등)
- ④ 질환(특히 소아 전염성 질환 이환여부 등)
- ⑤ 영양(수유방법, 비타민 투여, 식이의 선호도 등)
- ⑥ 성장과 발육
- ⑦ 예방접종
- ⑧ 습관(식사, 수면, 대소변 가리기, 야뇨증, TIC등) + 손가락 빨기

▶ 가족력 :

알레르기, 결핵, 경련질환, 혈액질환 .열성경련인자, 결핵, 매독, 심장, 신장, 간염, 정신병, 선천성 기형 등

▶ 사회력 : 가정환경, 유치원 학교의 친구

▶ 계통별 병력 : 양방? 문진

- 이비인후과 : 분비물, 수명증, 복시, 인후통, 시력변화 등

- 호흡기 : 호흡변화, 흉통, 기침, 가래, 천명

- 소화기 : 구토, 설사, 변비, 황달, 복통

- 심혈관계 : 청색증, 부종, 호흡장애, 심통, 실신

- 비뇨생식기 :

야뇨, 다뇨,頻뇨, 배뇨곤란, 혈뇨, 농뇨 등 (IgA 신병증)

- 신경근육 :

두통, 현훈, 경련, 진전, 근육관절통, 마비, 감각 및 언어장애

- 사지 : 관절통, 부종, 근력, 기형, 운동제한 등

- 전신적 : 체중감소, 피부색, 체온, 피로

▶ 기타 : 寒熱, 汗, 頭身痛, 二便, 음식, 二便, 수면, 胸腹 등

평소에 추위, 더위 타는지 / 대변의형태 / 수면시 이가는지 / 비위허약시 눈뜨고 자는지.

가슴이 답답하고 해수기천 : 痰阻氣道, 폐기불선의 가능성이 크다

복통의 표현을 알아두기

4. 切診 (절진)

1. 정상 小兒脈 : 和平하고 성인에 비해 細軟하다.

- 아래보다 빠르면 數脈, 느리면 遲脈

(평균 성인의 1호흡을 1식으로 했을 때)

- 신생아 : 7~8至(120-140/min)

- 1세 : 6~7至(110-120/min)-

- 4세 : 6至(110회/min)

- 8세 : 5至(90회/min)

2. 나이와 방법

- 3세 이후 절진이 가능

- 2,3세 이전 : 察指紋

- 진맥은 안정시나 잘 때 하는 것이 좋다

- 소아는 촌구맥 부위가 짧으므로 “一指定三關”의 방법을 사용한다 → 모지 또는 식지를 이용한다

3. 병증맥

- 기본맥 : 浮 沈 遲 數 有力 無力(表裏寒熱虛實)

- 滑脈 : 痰, 食積

- 弦脈 : 驚風 高혈압 (복통)

- 濡脈 : 氣血不足 濕重

- 結代脈 : 心氣不足

- 芤脈 : 失血
- 緊脈 : 통증

3절. 辨證

썸 : ppt 내용이 진짜진짜 많아서 교수님이 흑흑 넘어가서 다 정리하지 못했습니다. 교과서에 있으니 약마에 나오면 그때 정리하도록 하겠습니다!

辨證 : 四診에서 얻은 맥과 증의 기초 위에 변증강령을 종합 분석 귀납하여 질병이 성질과 부위 그리고 轉變의 단계를 확정짓는 것

a. 五臟辨證

- 소아변증에 가장 많이 사용
- 소문의 지진요대론에서 나타나서 전율의 소아약증직결에서 팔강변증과 결합하여 보충하였고, 명대에 이르러 전율의 오장증치학설이 크게 발전함. 절 밑에 표 있어요!

b. 八綱辨證 ★(9개년)

▶ 辨陰陽 : 음증과 양증 / 음허와 양허 / 망음과 망양

- 陰證 : 睡喜伏臥 縮手卷足 面好向壁 舌質淡而胖嫩 등
 - 陽證 : 睡喜仰臥 揚手擲足 多言 煩躁不安 呼吸氣粗 등
 - 陰虛 : 오후조열 형체소수 면협홍조 수족심열 허번불매
 - 陽虛 : 정신권태 소기나연 허한자출 대변희당 소변청희 면색청백
 - 亡陰 : 기부열 수족온 호흡기조 설홍건 맥세삭무력 갈희냉음 지문청조자체
 - 亡陽 : 외한지냉 한냉여주 정신위마 호흡기미 구불간 희열음 설백윤 맥미약육
- 절 지문담홍

▶ 辨表裏 (질병의 소재 부위와 병세의 深淺을 파악)

- 表證 : 發熱惡寒 頭痛身疼 鼻塞流涕 舌苔白薄 脈浮 등
- 裏證 : 畏熱 壯熱 新婚 謔語 煩燥 口渴 등
- 표한 : 오한발열 무한 비류청체 구불갈 순설담 설태백박 맥부긴
- 표열 : 발열유한 두목혼통 비류청체 구갈 순설홍 설태백박 맥부삭
- 표허 : 한출오통 루한불지 면색창백 순설담홍 설태백윤 맥부무력 지문부담
- 표실 : 두통신통 발열오한 무한 설태백 맥부긴유력 지문부체
- 리한 : 외한지냉 구불갈 오심구토 복통변당 완곡불화 대변색청 순설담백 설태백활 맥상침지
- 리열 : 발열 한출 변갈 구설생창 대변건결 소변단황 면적 순홍 설질홍 설태황 맥침삭
- 리허 : 신피소력 국성무력 라어언어 기단성저 호흡식미 불육유식 대변리 구설불지 설질담혹홍 설태백 혹 상심무태 맥침유력
- 리실 : 발열불발열 변갈 변조 聲壯 기조혹천 구설생창 홍복창만 대변비결 언발광 설질건홍 설태황조 맥침실

↳ 표한표실표열 -정기가 사기 못이겨서 땀안나고열 = 형방패독산

표허 -삼소음 계통

3. 辨寒熱 : 질병의 성질을 감별

▶ 寒證과 熱證(p.61)

- 허증 : 기육소수 면색광백 정신권태 소기소언 성저식미

- 국성무력 식소변당 순설담홍 설체고위 혹 肥嫩 맥허약

- 허한 : 외한 지냉 변당 뇨청 면백 순담 설담 태백 맥침무력

- 허열 : 오후조열 도한 인건 허번불매 수족심열 양관조홍 설홍태소 무태 맥허삭

- 실증 : 기부풍만 호흡기조 국성유력 홍격창만 복통거안 맥상유력

- 실열 : 장열변조 구갈인음 대변비결 소변황적 면적설홍 설태황조 맥상유력

▶ 寒熱錯雜

- 上熱下寒 : 目赤多眵비유탕체 인후동통 복부중한 제복냉통 하지불온 소변청백 성인이 더 많다.

아랫배 차고 소화안됨, 위로는 감기증상

- 上寒下熱 : 냉한 소변단적 소변노혈 대변건결

▶ 寒熱真假(p.62)

- 眞寒假熱 :

본래 寒證에 속하나 熱象이 나타나는 것. 비록 열상이 나타나나 옷과 이불을 덮으려 하지 않고 얼굴이 붉으나 浮紅嬌嫩, 설담윤, 비록 구갈이 있어도 물을 마시려 하지 않음. 더운물을 좋아한다. 맥부삭무력, 열이 피부에 있고 한이 장부에 있음

- 眞熱假寒 :

본래 熱證에 속하나 寒象이 나타나는 것- 수족불온 몸이 차나 옷과 이불을 덮으려 하지 않는다. 얼굴이 매암하나 순초조열 혹은 설홍건, 설유망자, 구갈희병음.. 맥침세유력. 한이 피부에 있고 열이 장부에 있다

▶ 辨虛實：正氣의 強弱과 病邪의 盛衰를 구분

- 虛實挾雜：환아가 평소 체질이 허약한데 外邪를 받거나 혹은 內傷乳食하면

正氣가 虛衰되고 邪氣는 더욱 퍼지게 되는 증후

c. 衛氣營血辯證 (발열성, 전염질환의 변증)

① 衛分證：온열병의 초기단계에서 많이 생기는데 병사가 처음 침입하여 병세가 가볍고, 病位가 皮毛와 肺에 있는 것으로 표증을 主한다. 發熱 微惡寒 頭痛

無汗或少汗 등

② 氣分證：不惡寒 反惡熱, 汗多, 口渴, 苔黃

③ 營分證：身熱夜深, 舌質紅絳, 心煩譫語 (발진 다발)

④ 血分證：身熱, 躁搖, 甚則狂越, 神昏 (출혈 다발)

五臟	主訴	本臟특징	主證	主色	主脈	辨證	
肝	風	常有餘	啼哭 目直視 頸項強急 四肢抽搐	青	弦	實	目直視 大叫 頸項強急 抽搐有力
						虛	抽搐無力
						熱	壯熱飲水 喘悶 口中氣熱 目直視 등
心	驚熱	熱爲火	驚悸 大熱 口渴引飲 不安 小便黃少	赤	數	實	發熱 煩渴 叫哭 喜仰臥 驚搖
						虛	臥而動悸不安
						熱	壯熱 口中氣熱 欲取冷 目內赤 등
脾	困	常不足	劇重困倦 多睡 不思飲食 泄瀉	黃	遲	實	困倦似睡 身熱飲水 使下黃赤
						虛	嘔吐 泄瀉色白 睡露睛
						熱	目內黃 尿黃
肺	喘	嬌嫩	噴嚏 流涕 鼻塞 咳嗽 喘急 悶亂 등	白	浮	實兼風冷	喘而氣盛 咳嗽 胸滿悶亂 渴不喜飲
						虛	哽氣或長出氣 喘而少氣 皮毛乾燥
						熱	喘急 鼻乾或衄血 手掐眉目鼻面
						虛熱	唇露紅色
腎	虛寒	常虛	目無精光 畏光 足脛寒 或逆冷	黑	沈	主虛無實	面浮晦暗或白或白 尿清長不禁